

SCOFF *pięć pytań*

Krótki kwestionariusz przesiewowy — pięć pytań, mniej niż 2 minuty. Wynik ≥ 2 = wskazanie do dalszej oceny. Czulość 85%, swoistość 90% (Hill 2010).

CZAS: 5 min · screening POZ, ginekologia, stomatologia · pierwszy kontakt

ŹRÓDŁO: Morgan, Reid & Lacey (1999, *BMJ*); Hill i in. (2010, walidacja)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **pięć pytań SCOFF** i zasady interpretacji (sekcja 1), zobacz **kiedy używać i jakie są ograniczenia** (sekcja 2). W sekcji 3 — Twój wynik. Sekcja 4 — co dalej.

DLACZEGO TO DZIAŁA

SCOFF to **najbardziej rozpowszechniony** kwestionariusz przesiewowy zaburzeń odżywiania, opracowany przez Morgana, Reida i Lacey'a (1999). Nazwa pochodzi od pierwszych liter pytań w wersji angielskiej: **S**ick, **C**ontrol, **O**ne stone, **F**at, **F**ood. **Cut-off ≥ 2** = pozytywny screening. Hill i in. (2010, walidacja): czulość 84,6%, swoistość 89,6%. Idealne narzędzie do **POZ, ginekologii, stomatologii, ER** — wykonanie trwa < 2 minuty. **Ważne:** SCOFF to narzędzie **przesiewowe**, nie diagnostyczne. Pozytywny wynik nie oznacza diagnozy — oznacza wskazanie do *pełnej oceny*. Negatywny wynik *nie* wyklucza ED.

01 Pięć pytań SCOFF

1 · SICK

Czy **prowokujesz wymioty**, ponieważ czujesz dyskomfort po jedzeniu lub nie chcesz, żeby to, co zjadłeś/-aś, zostało w żołądku?

2 · CONTROL

Czy martwisz się, że **straciłeś/-aś kontrolę** nad jedzeniem?

3 · ONE STONE

Czy **schudłeś/-aś znacząco** (ponad 6 kg) w ciągu ostatnich trzech miesięcy?

4 · FAT

Czy uważasz, że jesteś **za gruby/gruba**, mimo że inni mówią, że jesteś szczupły/szczupła?

5 · FOOD

Czy powiedziałbyś/powiedziałabyś, że **jedzenie zdominowało Twoje życie** — myśli o jedzeniu, planowanie, lęki, rytuały?

Interpretacja: punkt za każdą odpowiedź „tak”. **Wynik ≥ 2** = pozytywny screening — wskazanie do pełnej oceny diagnostycznej.

02 Kiedy używać · ograniczenia

KIEDY ZLECAĆ

POZ rutynowo u młodych dorosłych. Stomatolog gdy erozja szkliwa. Ginekolog przy zaburzeniach miesiączkowania. ER przy hipokaliemii.

OGRANICZENIA

Słabszy dla BED (brak kompensacji) i męskiej BN (ideał masy mięśniowej). Walidacja głównie na populacjach kobiecych. Niska swoistość u młodzieży.

Praktyka: SCOFF jest *pierwszym sygnałem*, nie ostatecznym werdyktem. Pozytywny wynik wymaga **pełnego wywiadu diagnostycznego** (handout „Wywiad diagnostyczny BN”) i oceny somatycznej. Negatywny — nie wyklucza ED, szczególnie gdy obraz kliniczny budzi wątpliwości lub gdy pacjent ukrywa objawy ze wstydu.

03 Mój wynik — wypełnij szczerze

Odpowiadaj „tak” lub „nie” obok każdego pytania. Sumuj odpowiedzi „tak”. Pamiętaj — to **narzędzie przesiewowe**, nie diagnoza. Wynik pomaga Tobie i klinicyście podjąć decyzję o dalszych krokach.

PYTANIE 1 (SICK)

— prowokowanie wymiotów; TAK / NIE

PYTANIE 2 (CONTROL)

— utrata kontroli nad jedzeniem; TAK / NIE

PYTANIE 3 (ONE STONE)

— znacząca utrata masy; TAK / NIE

PYTANIE 4 (FAT)

— przekonanie o byciu za grubym; TAK / NIE

PYTANIE 5 (FOOD) + SUMA

— jedzenie dominuje życie? Suma „tak” = ____ / 5

04 Co dalej — w zależności od wyniku

WYNIK ≥ 2

- Pełny wywiad u specjalisty
- Ocena somatyczna (lekarz POZ)
- Konsultacja w poradni zaburzeń odżywiania
- Nie odkładaj — wczesna interwencja działa

WYNIK 0–1

- Niska prawdopodobność klinicznego ED
- Ale: jeśli czujesz, że coś jest „nie tak” wokół jedzenia, ciała, kontroli — i tak skonsultuj się
- SCOFF nie wyłapuje wszystkich obrazów (BED, męska BN)

Klucz: SCOFF to *pierwszy krok*, nie ostateczny werdykt. Jego wartość polega na **szybkości** i **dostępności** — pięć pytań w mniej niż dwie minuty. Hill i in. (2010): w POZ rutynowe użycie SCOFF zwiększyło wykrywalność ED *czterokrotnie* w porównaniu z brakiem screeningu. Czułość 84,6%, swoistość 89,6% — to bardzo dobre parametry dla narzędzia przesiewowego. Polska wersja SCOFF jest dostępna i walidowana. **Jeśli Twój wynik to ≥ 2** — nie panikuj, ale *nie odkładaj* konsultacji. Jeśli wynik 0–1, ale czujesz, że coś jest „nie tak” — **zaufaj sobie, skonsultuj się mimo wszystko**. SCOFF nie wyłapuje wszystkich obrazów (np. BED bez kompensacji, męska BN z muscle dysmorphia). Konsultacja u specjalisty da pełną odpowiedź. Pierwszy krok — kontakt z lekarzem POZ lub **poradnią zaburzeń odżywiania**.